



PROTOCOLO PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL – IMPLANON

Prefeitura Municipal de Canoinhas
Secretaria Municipal de Saúde

Prefeita

Juliana Maciel Hoppe

Secretária de Saúde

Francieli da Costa Colla

Elaboração

Mahara Luana Cruz dos Santos
(Supervisora – Saúde)

Colaboração e Revisão

Alexandra Lavina Iglowski
(Enfermeira - Coordenadora da Atenção Primária)

Daniela Kamiya
(Enfermeira)

Micheli Zaffari Giuriatti
(Supervisora – Saúde)



INTRODUÇÃO

De acordo com a Constituição Federal de 1988 “O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, sendo vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”.

As ações voltadas para o planejamento reprodutivo referem-se à oferta de informações e acompanhamento quanto a métodos e técnicas para a concepção e a anticoncepção, estando a usuária com informações suficientes para que possa escolher, com o auxílio do profissional de saúde, qual método utilizar. Na atenção em anticoncepção, é muito importante oferecer diferentes opções de métodos anticoncepcionais para todas as etapas da vida reprodutiva, de modo que as pessoas tenham a possibilidade de escolher o método mais apropriado às suas necessidades e circunstâncias de vida.

O planejamento reprodutivo permite:

- que as mulheres tomem decisões sobre quando e querem ter filhos;
- a ampliação do intervalo entre gestações e partos;
- reduz as taxas de mortalidade materna e infantil;
- a diminuição das taxas de gestações não planejadas e de abortamentos provocados.

CRITÉRIOS PARA OFERTA DE IMPLANTE

Poderão ser elegíveis mulheres e adolescentes de **14 a 49 anos**, prioritariamente nas seguintes situações:

1. Multíparas (três ou mais partos) com dificuldade de adesão a outros métodos contraceptivos;
2. Mulheres em risco social (situação de rua, vítima de violência doméstica, vítima de abuso, alta vulnerabilidade, institucionalizadas ou usuárias de drogas);
3. Portadoras dos seguintes CID's: PVHIV (B24), Esquizofrenia (F20), Retardo Mental (F72), Síndrome de Down (Q90), Paralisia Cerebral (G80), e outros transtornos mentais graves e severos;
4. Histórico de filho com malformações congênitas ou síndromes genéticas.
5. Adolescentes de 14 a 19 anos, com uma ou mais gestações prévias;
6. Adolescentes de 14 a 19 anos com dificuldade de adesão a outros métodos;



7. Usuárias com contraindicação absoluta a outros métodos contraceptivos, mediante indicação, justificativa e avaliação realizadas por médico ou enfermeiro da Rede Municipal de Saúde de Canoinhas.

CONTRAINDICAÇÕES E RISCOS

- Câncer de mama ou outros tumores progestágenos dependentes;
- Gestação confirmada ou suspeita de gravidez;
- Distúrbio tromboembólico venoso ativo;
- Presença ou histórico de tumor hepático, benigno ou maligno; ou histórico de doença hepática grave, enquanto os valores dos testes de função hepática não retornarem ao normal;
- Sangramento uterino anormal não diagnosticado;
- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer componente de Implanon.

FLUXO DE ATENDIMENTO

O atendimento inicia-se na consulta médica ou de enfermagem, com avaliação de elegibilidade clínica e social. Deve ser realizado teste rápido de gravidez imediatamente antes do procedimento, leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A inserção é realizada por profissional médico capacitado, com registro em prontuário e acompanhamento posterior na Unidade Básica de Saúde.

1. Consulta Inicial (médica ou de enfermagem):

- Oferta e discussão de todos os métodos disponíveis no município (pílula, injetável, DIU de cobre, implante).
- Avaliação de elegibilidade segundo critérios clínicos e sociais.

2. Verificação de insumos:

- Confirmar disponibilidade do implante e materiais na Unidade de Saúde.
- Se disponível: realizar inserção no mesmo dia ou conforme agenda, priorizando casos vulneráveis.
- Se indisponível: solicitar o insumo à Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e agendar procedimento.

3. Documentos e exames:

- Realizar Teste Rápido de Gravidez imediatamente antes do procedimento.
- Verificar realização de citopatológico nos últimos 6 meses;



- Ler e coletar assinatura do Termo de Consentimento (Anexo I), arquivando na unidade.

4. Procedimento:

- Inserção realizada por profissional médico.
- Registrar no prontuário justificativa, critérios de elegibilidade e orientações fornecidas.

5. Acompanhamento pós-inserção:

- Retorno para avaliação de possíveis efeitos adversos.
- Manejo clínico e aconselhamento contínuo na Unidade Básica de Saúde (UBS).

REGISTRO DO PROCEDIMENTO

Para registro do procedimento de inserção ou retirada do implante subdérmico liberador de etonogestrel, selecione um dos procedimentos no sistema de informação de prontuário eletrônico:

- 03.01.04.017-6 - inserção do implante subdérmico liberador de etonogestrel
- 03.01.04.018-4 - retirada do implante subdérmico liberador de etonogestrel

Codificação CID/CIAP

Z300 – Aconselhamento sobre contracepção
Z308 – Outro procedimento anticoncepcional
Z309 – Procedimento anticoncepcional não identificado
CIAP W14 – Contracepção

Esses códigos podem pontuar no indicador de saúde da mulher relacionado a boa prática de saúde sexual e reprodutiva.

INSERÇÃO E REMOÇÃO DO IMPLANTE

- O implante pode ser inserido até 5 dias após o início da sua menstruação (para garantir que não há gravidez).
- Nas puérperas, pode ser colocado imediatamente após o parto a depender do desejo da mulher. É eficaz logo após a colocação.
- É colocado na parte interna do braço, abaixo da pele, como se fosse uma injeção. É necessária anestesia no local para inserção do implante. Pode ocorrer alguma dor, algum inchaço ou hematoma pequeno no local da colocação.



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL

Composição: Etonogestrel

Apresentação: Consiste num bastonete de 40 mm x 2 mm feito de plástico (etilenovinilacetato) contendo 68 mg do progestágeno etonogestrel (derivado do desogestrel), para ser inserido preferencialmente na face interna do membro superior. Libera inicialmente 60-70 mcg/dia, diminuindo para 35-45 mcg/dia no final do primeiro ano, 30-40 mcg/dia no segundo ano e 25-30 mcg/dia no final do terceiro ano.

Informações sobre o produto: O implante subdérmico é um método de contracepção reversível de longa ação (3 anos) altamente efetivo, sem nenhuma gravidez identificada em estudos com um grande tamanho amostral ^(1,2) ou índice falha inferior a 0,08 ⁽¹⁾.

Entre as vantagens dos implantes está a possibilidade de uso no período puerperal imediato, onde a ovulação pode ocorrer a partir do 28º dia. Na inserção imediata há uma menor probabilidade de sangramento irregular e de descontinuação sem interferência na amamentação ou crescimento do bebê.

De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS-WHO) – Born Too Soon, The Global Action Report on Preterm Birth, 2012 – uma das importantes causas evitáveis de prematuridade é o intervalo interpartal < 2 anos, o que reforça a necessidade de uma política eficaz de planejamento familiar no período puerperal imediato ⁽³⁾.

Mecanismo de Ação: alterações no muco cervical e na motilidade tubária que são desfavoráveis à migração espermática, assim inibindo a fertilização. Nas doses maiores ocorre também a inibição da secreção de gonadotrofina, inibindo a maturação folicular e a ovulação. Existe também um efeito secundário, tornando o endométrio não receptivo à implantação ⁽¹⁾.

Alguns estudos sugerem que a concentração sérica do etonogestrel pode ser afetada pelo peso corporal da mulher. No entanto, apesar dessa concentração ser menor em mulheres obesas, este fato não está relacionado à maior taxa de falha do implante comparado com mulheres de peso normal.

Manter o acompanhamento da usuária na Unidade de Saúde para verificação e manejo de possíveis eventos adversos podendo ser necessárias intervenções médicas (tratamento e/ou aconselhamento).

Os principais efeitos são:

- * Cefaléia que ocorre em menos de 15% das mulheres principalmente nas primeiras semanas após a inserção do implante de etonogestrel ⁽⁵⁾ é transitória e desaparece em torno de 8 semanas, se necessário pode ser prescritos analgésicos e anti-inflamatórios não esteróides;
- * Mastalgia segue o exemplo acima;



* Acne pode estar presente em 13 a 15% das usuárias, costuma ser de grau leve, caso este efeito incomodar a paciente pode ser prescrito drogas antiandrogênicas (espironolactona..)

* Tontura, mal-estar, alteração de peso (12%), ansiedade e depressão (6%), mastalgia (10%) e dor abdominal (5%) tendem a diminuir com o passar do tempo ^{(5),(7)};

casos de tromboembolismo e infarto agudo do miocárdio associados ao método são de 12/100.000 mulheres/ano, menores que dos contraceptivos orais combinados.

* Sangramento anormal - o seu manejo consiste em primeiro lugar realizar um aconselhamento pré-inserção orientando a usuária sobre o padrão de sangramento menstrual esperado com uso do implante principalmente o esclarecimento que a irregularidade menstrual não significa falha do contraceptivo. As taxas de amenorreia são significativamente mais altas após dois anos de uso. Apesar do tratamento devemos salientar que não há como prevenir a recorrência dos sintomas visto que o sangramento tem origem pelo progestágeno, salientando que em 6 meses após a inserção o padrão do sangramento tende a ficar mais favorável. Deve-se investigar outras patologias que podem estar causando o sangramento quando este ultrapassar os seis meses após a inserção e/ou não responder às drogas utilizadas ou quando surgirem sintomas não relacionados à implantação como dispareunia, sangramento nas relações sexuais e dor pélvica, nestes casos, são recomendados o exame pélvico vaginal especular vaginal, especular e ultrassonográfico.

TABELA 1 - DROGAS USADAS PARA CESSAR O SANGRAMENTO

Melhores que placebo	Efeitos misto	Sem efeito	Recomendado por especialistas porém sem estudo
Ácido tranexâmico 500 mg 8/8h 5 a 7 dias Anticoncepcional combinado (30 µg EE+150 µg LNG 1 cp/dia por 1 a 3 ciclos) Estrogênio – EE 50 µg/dia por 21 dias (equivale a 5 mg de valerato de estradiol por dia)	AINE: Ibuprofeno 400 mg 8/8h 5 a 7 dias Ácido mefenâmico 500 mg 8/8h por 5 a 7 dias Doxiciclina 100 mg 1cp 12/12h por 7 dias	Mifepristone Vitamina E Venotônicos Tamoxifeno	Desogestrel 75 mcg 1 cp/dia por 1 a 3 meses

(Ou outros fármacos e condutas que o médico entender coerente)



ANEXO I -

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL

Eu declaro que o/a Dr(a) _____
CRM/SC nº _____ informou que tendo em vista o DESEJO DE CONTRACEPÇÃO COM MÉTODO DE LONGA DURAÇÃO, ser indicado o uso de implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel. Esclareceu-me que:

1. O Implante subdérmico(SD) de etonogestrel é um método contraceptivo de longa duração e reversível.
2. O implante SD de etonogestrel deve ser inserido sob a pele na face medial do braço não dominante (que você não escreve), sob anestesia local.
3. O índice de falha é de 0.05% ao ano (5 gravidezes em 10.000 mulheres que usem o implante).
4. Uma pequena quantidade de progesterônio etonogestrel (um tipo de hormônio feminino) é liberada continuamente, passando do implante para o corpo, resultando em um efeito anticoncepcional por um período de 03 anos.
5. Em alguns casos o procedimento de inserção e/ou retirada pode haver formação de cicatriz no local do implante.
6. A inserção ou remoção do implante pode causar irritação leve, dor e coceira no local. Pode ocorrer também hematoma no local da inserção.
7. O contraceptivo pode ser removido a qualquer momento, mas deve ser removido após o período de 03 anos de uso. Esse procedimento necessita uso de anestesia local.
8. Como em todos os contraceptivos apenas com progesterona, o implante SD de etonogestrel pode mudar o padrão do sangramento vaginal. O padrão menstrual que poderá ocorrer com o uso do implante varia de mulher para mulher sendo de difícil previsão, mas em média, em 52% dos casos ocorrem amenorreia (ausência de sangramento) ou sangramento infrequente, em 20% dos casos não ocorre alteração do fluxo menstrual (sangramento normal), em 17,7% ocorre um aumento no menstrual (sangramentos prolongados) e em 6,7% sangramentos frequentes.
9. Segundo os dados dos estudos realizados com o implante SD de etonogestrel, das mulheres que apresentavam acne, no momento da inserção, a maioria delas (cerca de 59%), teve melhora no quadro. Em cerca de 14% a acne ocorreu sem história prévia e 10% pioraram a condição anterior.
10. Em raros casos podem ocorrer alguns efeitos adversos tais como aumento de peso, cefaleia, dor nas mamas.
11. Algumas medicações podem interferir no perfeito funcionamento do implante como antiepiléticos e remédios para tratamento da tuberculose.
12. O Implante SD de etonogestrel não previne contra infecção por HIV ou qualquer outra doença sexualmente transmissível.
13. Em caso de dor fui orientada a fazer uso de medicação analgésica.
14. Fui orientada a retornar à consulta de forma breve em caso de dor local intensa, hematoma extenso, febre, saída de secreção purulenta local ou quaisquer outras intercorrências.
15. Declaro ter recebido comprovante contendo data de inserção, data máxima de retirada e número do lote do produto.

Entendi as explicações que foram prestadas em linguagem clara e simples, esclarecendo-me todas as dúvidas que me ocorreram. Também entendi que a qualquer momento prévio a inserção e sem necessidade de dar nenhuma explicação poderei revogar o consentimento que agora presto.

Assim, declaro agora que estou satisfeita com a informação recebida e que compreendo o alcance e riscos do tratamento. Por esta razão e nestas condições, consinto que realize a inserção do implante contraceptivo proposto.

Canoinhas, ____ / ____ / ____

Nome: _____ CPF _____

Assinatura: _____



FLUXO PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO





REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Darney P, Zieman M, Barss V. Etonogestrel contraceptive implant. UpToDate, Literature review current through: Apr 2013. www.uptodate.com, acessado em 18/05/2013.
- Mavranouzouli I. LARC Guideline Development Group. The cost-effectiveness of long acting reversible contraceptive methods in the UK: analysis based on a decision-analytic model developed for a National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) clinical practice guideline. *Hum Reprod*. 2008 Jun; 23 (6): 1338-45.
- Sivin I. Risks and benefits, advantages and disadvantages of levonorgestrel-releasing contraceptive implants. *Drug Saf*. 2003; 26 (5): 303-35.
- Xu H, Wade JA, Peipert JF, Zhao Q, Madden T, Secura GM. Contraceptive failure rates of etonogestrel subdermal implants in overweight and obese women. *Obst Gynecol* 2012;120(1):21-6.
- Mwalwanda CS, Black KI. Immediate post-partum initiation of intrauterine contraception and implants: A review of the safety and guidelines for use. *Aust NZJ Obstet Gynaecol*. 2013 May 2. Doi: 10111/ajo.12095.
- Letti Müller AL, Lopes Ramos JG, Martins-Costa SH, Palma Dias RS, Valério EG, Hammes LS, Glitz CL, Zucatto AE, Vettori DV, Magalhães JA. Transvaginal ultrasonographic assessment of the expulsion rate of intrauterine devices inserted in the immediate postpartum period: a pilot study.
- Mansour D, Bahamondes L, Critchley H, Darney P, Fraser IS. The management of unacceptable bleeding patterns in etonogestrel-releasing contraceptive implant users. *Contraception*. 2011;83(3):202-10 *Contraception*. 2005 Sep;72(3):192-5.
- Sidney S, Cheetham TC, Connell FA, Ouellet-Hellstrom R, Graham DJ, Davis D, Sorel M, Quesenberry CP Jr, Cooper WO. Recent combined hormonal contraceptives (CHCs) and the risk of thromboembolism and other cardiovascular events in new users. *Contraception*.
- Abdel-Aleem H, d'Arcangues C, Vogelsong KM, Gaffield ML, Gülmezoglu AA. Treatment of vaginal bleeding irregularities induced by progestin only contraceptives. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;10:CD003449
- Mansour D, Bahamondes L, Critchley H, Darney P, Fraser IS. The management of unacceptable bleeding patterns in etonogestrel-releasing contraceptive implant users.
- Committee on Adolescent Health Care Long-Acting Reversible Contraception Working Group, The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Committee opinion no. 539: adolescents and long-acting reversible contraception: implants and intrauterine devices. *Obstet Gynecol*. 2012 Oct; 120 (4): 983.



- Bachelot A, Chabbert-Buffet N, Salenave S, Kerlan V, Galand-Portier MB. Antiandrogen treatments. *Ann Endocrinol (Paris)*. 2010;71(1):19-24
- Abdel-Aleem H, d'Arcangues C, Vogelsong KM, Gaffield ML, Gülmezoglu AA. Treatment of vaginal bleeding irregularities induced by progestin only contraceptives. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;10:CD003449
- Mansour D, Bahamondes L, Critchley H, Darney P, Fraser IS. The management of unacceptable bleeding patterns in etonogestrel-releasing contraceptive implant users. *Contraception*. 2011;83(3):202-10
- Abdel-Aleem H, d'Arcangues C, Vogelsong KM, Gaffield ML, Gülmezoglu AA. Treatment of vaginal bleeding irregularities induced by progestin only contraceptives. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;10:CD003449.
- Dean, Gillian; Schwarz, Eleanor Bimla (2011). "Intrauterine contraceptives (IUCs)". In Hatcher, Robert A.; Trussell, James; Nelson, Anita L.; Cates, Willard Jr.; Kowal, Deborah ;Policar, Michael S. *Contraceptive technology* (20th revised ed.). New York: Ardent Media. pp. 147–191
- Luis Bahamondes, M Valeria Bahamondes, Ilza Monteiro. (2008), "Levonorgestrel releasing intrauterine system: uses and controversies.", *Expert Review of Medical Devices* 4: 437
- Petta C, Ferriani R, Abrao M, Hassan D, Rosa E Silva J, Podgaec S, Bahamondes L (2005). "Randomized clinical trial of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and a depot GnRH analogue for the treatment of chronic pelvic pain in women with endometriosis.". *Hum Reprod* 20 (7): 1993–8
- Sheng, J; Zhang, WY; Zhang, JP; Lu, D. (2009), "The LNG-IUS study on adenomyosis: a 3-year follow-up on the efficacy and side effects of the use of levonorgestrel intrauterine system for the treatment of dysmenorrheal associated with adenomyosis", *Contraception* 79 (3): 189–193
- Faundes A, Alvarez F, Brache V, Tejada A (1988). "The role of the levonorgestrel intrauterine device in the prevention and treatment of iron deficiency anemia during fertility regulation". *Int J Gynaecol Obstet* 26 (3): 429–33
- Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C (2006). "Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding.". In Marjoribanks, Jane. *Cochrane Database Syst Rev* (2): CD003855 Winner, B; Peipert, JF; Zhao, Q; Buckel, C; Madden, T; Allsworth, JE; Secura, GM. (2012), "Effectiveness of Long-Acting Reversible Contraception", *New England Journal of Medicine* 366 (21): 1998–2007.
- Bula Mirena
- Bahamondes L, Hidalgo M, Petta CA, Diaz J, Espejo-Arce X, Monteiro-Dantas C. (2003), "Enlarged ovarian follicles in users of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and contraceptive implant", *J. Reproduc. Med.* 48 (8): 637–640



Sivin, I; Stern, J; Coutinho, E; Mattos, CE; el Mahgoub, S; Diaz, S, et al. (1991), "Prolonged intrauterine contraception: a seven-year randomized study of the levonorgestrel 20 mcg/day (LNg 20) and the Copper T380 Ag IUDS", Contraception 44: 473–480

WHO (2010). "Intrauterine devices (IUDs)". Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (4th ed.). Geneva: Reproductive Health and Research, WHO.

Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care Clinical Effectiveness Unit (2004). "FFPRHC Guidance (April 2004). The levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS) in contraception and reproductive health". J Fam Plann Reprod Health Care 30 (2): 99–109.

Mohllajee, AP; Curtis, KM; Herbert, PB. (2006), "Does insertion and use of an intrauterine device increase the risk of pelvic inflammatory disease among women with sexually transmitted infection? A systematic review", Contraception 73 (2): 145–153

Mansour, D; Gemzell-Danielsson, K; Inki, Pirjo; Jensen, JT. (2011), "Fertility after discontinuation of contraception: a comprehensive review of the literature", Contraception 84 (5): 465–477

Madden T, Schreiber CA, Ecker K. Intrauterine contraception: Candidates and device selection. 2021. Disponível em www.uptodate.com. Acessado 01/06/2021.



MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA DE SAÚDE

